HISTORIAL FARMACOLÓGICO DE REACCIONES DÉRMICAS Y PICORES

Paciente: Javi (67 aæos) | Documento de apoyo para Consulta de Alergología | Hoja Resumen

OBJETIVO: Aportar al especialista el listado completo de medicamentos tomados y los síntomas cutÆneos manifestados.
OBSERVACIÓN: Picores a menudo transitorios o autolimitados. Se incluye la Atorvastatina como ejemplo de perfecta tolerancia.

Familia Farmacológica	Medicamentos evaluados (19) y Reacción cutÆnea observada	Evolución y Tolerancia
1. BetalactÆmicos (Penicilinas)	**- CLAMOXIL (1997): Sarpullido eritematoso en** el pecho. **- AMOXICILINA 750 (2017): Picores leves y** palpitaciones al 4o día (11 comp). - Analítica previa (2002): RAST Amoxicilina <0,35 (limítrofe).	**REACCIÓN REPETIDA** Se retiróen 1997. En 2017 completóciclo con molestias leves. Sospecha de sensibilidad a penicilinas.
2. Fluorquinolonas (Quinolonas)	**- VELMONIT (Ciprofloxacino, 1999):** Sarpullido en pecho (retirado 3d). **- SURNOX (Ofloxacino, 2001): Picores en** espalda que cedieron al 6o día. **- LEVOFLOXACINO 500 (2025): Picores** brazos/piernas que remitieron el 7o día.	**PICOR QUE REMITE** Con Ofloxacino y Levofloxacino el picor desapareciódurante el tratamiento y pudo completarse la pauta.
3. Macrólidos (Antibióticos)	**- KLACID UNIDIA (Claritromicina 500, 2006):** Picores intensos en piernas y taquicardia a la 3a pastilla. **- AZITROMICINA 500 (2015): Picor breve en** brazos de 3 horas. **- AZITROMICINA (2017): Tomado de nuevo con** tolerancia completa normal.	**TOLERANCIA CLARA** Claritromicina no se tolera (retirada de urgencia). Azitromicina se tolera perfectamente sin problemas.
4. Colesterol (Hipolipemiantes)	**- EZETIMIBA 10 (2026): Prurito cutÆneo** continuo 15 días (precisóAerius). **- PITAVASTATINA (2026): Picores difusos a la** 3a semana (retirado con Aerius). **- ATORVASTATINA 20 (2022-2026): CERO** PICORES. Excelente tolerancia.	**TOLERANCIA TOTAL** El picor depende del fÆrmaco concreto. Atorvastatina es perfectamente tolerada y mantiene LDL en 64.
5. Corticoides (Nasal y Depósito)	- NASONEX (Mometasona nasal, 2024): Picores fugaces de pocos minutos. - INFILTRACIÓN CORTICOIDES (Mayo 2024, cresta ilíaca izq.): Picores corporales durante 5 días que se quitaron solos por completo.	**AUTOLIMITADO** Sin afectación respiratoria ni alergia grave. Los picores desaparecieron solos en 5 días.
6. Otros Antibióticos (Sulfamida / Tetraciclina)	- BRONGENIT (Cotrimoxazol, 1999): Picores a la 3a pastilla (retirado 6a). - VIBRACINA (Doxiciclina, 1999): Sarpullido en costado el œltimo día (día 7).	**REACCIÓN FINAL** Sarpullido tardío al terminar la pauta antibiótica; remitióen días posteriores.
7. Otros Tratamientos (SNC, Vitaminas, Tópicos)	- ALPRAZOLAM 0,25 (2004): Picores tipo pinchitos; duró5 días y se pasósolo. - BENERVA (Vit B1, 2003-04): Granos frente/pecho y dedo pie; cedióen 5d. - MICOSPORT (Bifonazol, 2004): Granos al 7o día tras curar hongo. - PERMIXON 160 (Serenoa, 2022/25): Picores leves en extremidades. - PROCTOIAL RECTAL (2023): Escozor local circunscrito a mucosa.	**PROCESOS BENIGNOS** Molestias leves autolimitadas en unos 5 días o por contacto tópico local, sin repercusión general.

** Documento extraído del seguimiento cronológico personal de tratamientos farmacológicos. Conserva copia completa detallada.*